

PAUSE CARDIO ❤️

Nouveautés de la semaine du 29 août 2026

23 nouveautés cette semaine, dont 5 susceptibles de changer votre pratique.

CARDIOMYOPATHIES & MYOCARDITES

Changement de pratique

Essai randomisé de phase 3 · ACACIA-HCM

Aficamten for Symptomatic Nonobstructive Hypertrophic Cardiomyopathy

NEJM · 28 août 2026 · présenté en Hot Line à l'ESC 2026 (Munich)

La forme non obstructive de la cardiomyopathie hypertrophique n'avait aucun traitement démontré, et le mavacamten y avait échoué en 2025 (ODYSSEY-HCM). L'aficamten améliore à la fois la capacité d'effort mesurée et l'état de santé rapporté par le patient à 36 semaines. Le gain est réel mais modéré, et 10 % des patients voient leur FEVG passer sous 50 %.

Au cabinet : pour la première fois, un traitement médicamenteux fait bouger la CMH non obstructive symptomatique, là où l'on n'avait que des conseils et des bêtabloquants. Le patient gêné malgré un traitement bien conduit peut désormais être adressé au centre expert pour discuter d'un inhibiteur de myosine — en lui disant honnêtement que le gain moyen est modeste. Retenir surtout le suivi : échocardiographie de contrôle programmée, car un patient sur dix voit sa FEVG descendre sous 50 % sous traitement.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)

INSUFFISANCE CARDIAQUE

Changement de pratique

Recommandations ESC 2026

2026 ESC Guidelines for the management of heart failure

European Heart Journal · 28 août 2026 · présentées à l'ESC 2026 (Munich)

Première refonte complète depuis 2021. La catégorie intermédiaire « FEVG modérément altérée » disparaît : il n'y a plus que deux phénotypes, FEVG < 50 % et FEVG ≥ 50 %. Les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes passent en classe I quelle que soit la FEVG, et les incrélines entrent dans le texte pour l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée avec obésité.

Au cabinet : deux gestes à intégrer dès la prochaine consultation. D'abord, cesser de traiter la tranche 41–49 % comme une zone à part : sous 50 % de FEVG, on déroule les quatre piliers. Ensuite, la spironolactone (ou l'éplérénone) devient un traitement de fond à proposer aussi à FEVG préservée, avec la surveillance habituelle de la kaliémie et de la créatinine à une semaine puis à un mois. Chez l'insuffisant cardiaque à FEVG préservée et obèse, penser désormais au sémaglutide ou au tirzépate. Enfin, changer de vocabulaire dans les courriers : on parle de décompensation, pas d'insuffisance cardiaque aiguë.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)

Fifth Universal Definition of Myocardial Infarction (2026)

European Heart Journal · 28 août 2026 · publication simultanée dans *Circulation* et *JACC* · ESC 2026 (Munich)

Les quatre grandes sociétés abandonnent les numéros — type 1, type 2, type 4c — au profit de trois catégories que l'on peut expliquer à un patient : infarctus **primaire** (problème de l'artère coronaire elle-même), **secondaire** (déséquilibre entre apports et besoins en oxygène) et **lié à un geste** (dans les 30 jours d'une procédure ou d'une chirurgie).

Au cabinet : le patient qui arrive avec un compte rendu d'hospitalisation récent parlera désormais d'infarctus « primaire », « secondaire » ou « lié à un geste ». C'est une bonne nouvelle pour la consultation : on peut expliquer sans jargon qu'un infarctus secondaire n'est pas un accident de plaque et n'appelle pas la même stratégie antithrombotique ni le même bilan coronaire — c'est la cause déclenchante qu'il faut traiter. Penser aussi à la dissection coronaire spontanée devant un infarctus de la femme jeune sans facteur de risque.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)

Anticoagulation for Atrial Fibrillation with Intermediate Stroke Risk

NEJM · 28 août 2026 · présenté en Hot Line à l'ESC 2026 (Munich)

Premier essai randomisé dans la zone grise du score CHA₂DS₂-VASc à 1 chez l'homme ou 2 chez la femme : chez 1 803 patients coréens, l'anticoagulant oral direct divise par trois le risque d'AVC, d'embolie, d'hémorragie grave ou de décès cardiovasculaire à deux ans, sans excès de saignement.

Au cabinet : devant une fibrillation atriale avec un seul facteur de risque — un hypertendu de 60 ans, un diabétique, un patient de 65 à 74 ans par ailleurs indemne —, la balance penche désormais vers l'anticoagulation plutôt que vers l'abstention, sans surcoût hémorragique observé. Ce n'est plus une opinion : c'est le premier essai randomisé de cette zone grise. Le petit nombre d'événements invite à rester nuancé chez le patient à haut risque de saignement, où la discussion garde tout son sens.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)

2025 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care

Circulation · 21 octobre 2025 · 152(16 suppl. 2)

Refonte complète des recommandations américaines de réanimation. Le volet réanimation avancée de l'adulte couvre défibrillation et cardioversion, abord des voies aériennes, médicaments et voies d'abord vasculaire, et prend position sur la double défibrillation séquentielle, la réanimation tête surélevée et l'échographie au lit du patient. Le volet soins post-arrêt fixe les objectifs de pression artérielle, d'oxygénation, de ventilation et de glycémie, et revoit contrôle thermique, coronarographie, assistance circulatoire, détection des crises convulsives et neuropronostic.

Au cabinet : c'est le texte de référence à avoir lu avant une garde en USIC, et l'argumentaire à citer pour la formation des équipes et l'implantation des défibrillateurs automatisés dans le bassin de vie.

[Article original](#) · [Soins post-arrêt](#)

Eplontersen for Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy

NEJM · 28 août 2026 · présenté en Hot Line à l'ESC 2026 (Munich)

Le plus grand essai jamais mené dans l'amylose cardiaque à transthyrétine est négatif : malgré une extinction efficace de la production hépatique de transthyrétine, l'eplontersen ne réduit ni les décès cardiovasculaires ni les événements cardiovasculaires récurrents à 140 semaines. Un résultat qui contraste avec le vutrisiran (HELIOS-B) et qui refroidit l'idée que tous les « silencers » se valent.

Au cabinet : rien à changer dans les ordonnances, mais un repère utile pour répondre au patient qui a lu quelque chose sur les « nouveaux traitements de l'amylose ». La classe des réducteurs de transthyrétine ne se comporte pas de façon homogène : le vutrisiran a démontré un bénéfice (HELIOS-B), l'eplontersen non. Chez un patient déjà sous tafamidis ou acoramidis, il n'y a à ce jour aucun argument pour ajouter cet antisens.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)

2026 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease and chronic kidney disease

European Heart Journal · 28 août 2026 · présentées à l'ESC 2026 (Munich)

Premier texte européen consacré au couple cœur-rein. Message central : tout patient recevant un diagnostic de maladie cardiovasculaire doit être dépisté pour une maladie rénale chronique, par le débit de filtration glomérulaire estimé et le rapport albumine/créatinine urinaire — les deux, pas l'un ou l'autre.

Au cabinet : ajouter le rapport albumine/créatinine urinaire à l'ordonnance de bilan de tout nouveau coronarien, insuffisant cardiaque, artéritique ou fibrillant — c'est un examen simple, sur un échantillon, que l'on ne demande pas assez. Un DFG normal ne suffit pas à écarter la maladie rénale. En cas d'anomalie, le triptyque bloqueur du SRA + iSGLT2 + statine est à mettre en place sans attendre l'avis néphrologique, qui reste indiqué pour les stades avancés ou l'albuminurie importante.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)

Predictive Utility of Coronary Artery Calcium Score Added to the PREVENT Atherosclerotic Cardiovascular Disease Equations

JAMA · 26 août 2026

Les recommandations lipidiques ACC/AHA 2026 réservent le score calcique aux risques estimés entre 3 et 10 % par les équations PREVENT. Cette analyse de la cohorte MESA valide ce ciblage : ajouté à PREVENT dans l'ensemble de la population, le score calcique n'améliore la discrimination que de façon marginale ; c'est à la frontière du traitement qu'il fait basculer la décision.

Au cabinet : ne pas demander un score calcique « pour voir » chez tout le monde. Il se justifie chez le patient dont le risque estimé est juste sous le seuil de traitement et qui hésite à prendre une statine : un score nul autorise à différer et à reconstruire, un score au-dessus de 100 fait passer dans une catégorie où le traitement ne se discute plus. Chez celui qui a déjà une indication franche, l'examen ne changera rien.

[Article original](#)

Transcatheter Aortic Valve Replacement or Medical Treatment for Paradoxical Low-Flow, Low-Gradient Aortic Valve Stenosis: REBOOT-PARADOX

JACC · 28 août 2026 · présenté à l'ESC 2026 (Munich)

Premier essai randomisé dans le rétrécissement aortique à bas débit et bas gradient à FEVG conservée, cette forme déroutante où la surface est serrée mais le gradient reste bas. Arrêté prématurément faute d'inclusions, il ne tranche pas sur la mortalité mais montre un gain net sur les symptômes.

Au cabinet : devant un bas débit paradoxal, pas de raison d'adresser en urgence pour un TAVI systématique ; mais pas de raison non plus de temporiser quand les symptômes s'installent. La stratégie soutenue par cet essai est celle d'une **surveillance rapprochée avec TAVI dès la dégradation clinique** — c'est en pratique ce que faisaient déjà la moitié des patients du bras médical. Vérifier au préalable que le bas gradient n'est pas une erreur de mesure : volume d'éjection indexé, alignement Doppler, contrôle tensionnel.

[Article original](#)

2026 ESC Guidelines on cardiac rehabilitation

European Heart Journal · 28 août 2026 · présentées à l'ESC 2026 (Munich)

La réadaptation cardiaque n'avait jamais eu de texte européen dédié. Celui-ci élargit nettement les indications au-delà du post-infarctus — insuffisance cardiaque, fibrillation atriale, après chirurgie ou remplacement valvulaire, cardiopathie congénitale, et patients sous traitement anticancéreux cardiotoxique — et légitime les programmes à domicile encadrés par des outils numériques.

Au cabinet : l'occasion de reprendre l'habitude de proposer une réadaptation au-delà du seul post-infarctus — après un remplacement valvulaire, chez l'insuffisant cardiaque stabilisé, chez le patient en fibrillation atriale déconditionné. Pour celui qui refuse le déplacement quotidien ou qui vit loin d'un centre, situation fréquente en Aveyron, la téléadaptation encadrée est désormais une option recommandée, et non un pis-aller.

[Article original](#) · [Communiqué ESC](#)

Cardiovascular Magnetic Resonance to Guide Defibrillator Implantation for LVEF of 36% to 50%: The CMR GUIDE Randomized Clinical Trial

JAMA · 28 août 2026 · présenté en Hot Line à l'ESC 2026 (Munich)

On espérait que la fibrose vue à l'IRM désignerait, parmi les FEVG entre 36 et 50 %, ceux qui méritent un défibrillateur. L'essai est négatif sur son critère principal ; la mort subite isolée baisse néanmoins des trois quarts, et tout le bénéfice se concentre avant 70 ans.

Au cabinet : ne pas annoncer à un patient à FEVG 40 % qu'une IRM montrant de la fibrose lui vaudra un défibrillateur : les recommandations ne bougeront pas sur cet essai. En revanche, l'IRM avec recherche de rehaussement tardif garde tout son intérêt chez le patient à FEVG modérément altérée, et chez le patient jeune porteur d'une fibrose étendue, la discussion en centre expert reste légitime — en prévenant que le bénéfice, s'il existe, se compte en une mort subite évitée pour une quinzaine d'implantations.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE [À connaître](#) Essai randomisé · POET-II

Response-tailored antibiotic treatment duration in left-sided infective endocarditis (POET-II)

NEJM · 28 août 2026 · présenté en Hot Line à l'ESC 2026 (Munich)

Chez 508 patients stabilisés sous antibiotiques pour une endocardite du cœur gauche, adapter la durée du traitement à la réponse clinique et biologique a permis d'économiser deux semaines d'antibiothérapie sans perte de sécurité. La contrepartie : davantage de rechutes.

Au cabinet : une décision hospitalière, mais qui change le suivi de ville. Un patient sortant d'endocardite avec « seulement » quatre semaines d'antibiotiques n'a plus forcément été sous-traité. En contrepartie, la surveillance post-sortie doit être serrée : fièvre, sueurs, asthénie, souffle nouveau ou syndrome inflammatoire justifient des hémocultures et un avis rapide, le risque de rechute étant environ trois fois plus élevé.

[Article original](#) · [Analyse TCTMD](#)

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE [À connaître](#) Essai randomisé · LOGICAL

Conservative Oxygen for Unresponsive Patients after Cardiac Arrest

NEJM · 6 août 2026 · 395(6):571–581

1 840 adultes restés comateux et ventilés en réanimation après un arrêt cardiaque, randomisés entre oxygénation conservatrice (alarme haute de SpO₂ à 95 %, FiO₂ ramenée à 0,21 tant que la SpO₂ reste au-dessus de 90 %) et oxygénation libérale : la survie avec bon devenir fonctionnel à 180 jours est la même.

Au cabinet : rien ne justifie de raboter la FiO₂ après un arrêt cardiaque récupéré : on maintient une SpO₂ au-dessus de 90 % sans viser plus bas, et l'énergie se porte sur les autres paramètres du post-arrêt.

[Article original](#)

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE [À connaître](#) Essai randomisé adaptatif · ICECAP

Duration of Therapeutic Hypothermia After Out-of-Hospital Cardiac Arrest: The ICECAP Randomized Clinical Trial

JAMA · 5 août 2026 · 71 hôpitaux américains

1 158 patients restés comateux après un arrêt cardiaque extrahospitalier, refroidis à 33 °C et randomisés entre dix durées de refroidissement allant de 6 à 72 heures : prolonger le refroidissement n'améliore pas le devenir neurologique à 90 jours, quel que soit le rythme initial. L'essai a été arrêté à l'analyse intermédiaire.

Au cabinet : à retenir pour la garde et pour la lecture des comptes rendus de réanimation : prolonger le refroidissement au-delà de quelques heures ne fait pas gagner de cerveau. Le cadre de référence reste les recommandations AHA 2025 signalées dans cette rubrique.

[Article original](#)

USIC · RÉANIMATION CARDIOLOGIQUE [À connaître](#) Essai randomisé · LEVOECMO

Levosimendan to Facilitate Weaning From ECMO in Patients With Severe Cardiogenic Shock: The LEVOECMO Randomized Clinical Trial

JAMA · 6 janvier 2026 · 335(1):60–69 · essai français

205 patients en choc cardiogénique sévère, sous ECMO veino-artérielle depuis moins de 48 heures, randomisés lévosimendan précoce contre placebo dans onze réanimations françaises : le sevrage de l'ECMO n'est pas plus rapide, et les arythmies ventriculaires sont plus fréquentes sous lévosimendan.

Au cabinet : chez un patient adressé en centre d'assistance, ne pas attendre du lévosimendan qu'il raccourcisse l'ECMO ; son usage systématique se paie d'un excès d'arythmies ventriculaires.

[Article original](#)

Left Ventricular Unloading in Anterior ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Without Shock: The STEMI Door to Unload Randomized Controlled Trial

JACC · 7 juillet 2026 · 88(1):76–90

527 patients avec infarctus antérieur sans choc, randomisés entre décharge du ventricule gauche par pompe micro-axiale pendant 30 minutes avant l'angioplastie et angioplastie immédiate : la taille de l'infarctus mesurée en IRM à J3–J5 est identique, avec davantage d'hémorragies et de complications vasculaires dans le bras décharge.

Au cabinet : l'idée de décharger avant de désobstruer ne résiste pas à l'épreuve de l'essai. Hors choc, la règle reste la reperfusion la plus rapide possible — c'est le message à tenir au patient comme au correspondant.

[Article original](#)

Artificial Intelligence-Enabled Acquisition and Interpretation for Screening Aortic Stenosis

JAMA Cardiology · 28 août 2026

Un algorithme guide l'acquisition d'une échographie focalisée puis l'interprète, pour détecter un rétrécissement aortique au moins modéré. Chez 1 302 patients examinés par des opérateurs *novices*, la sensibilité atteint **93 %** et la spécificité **96 %** (aire sous la courbe 0,99 en validation). La valeur prédictive positive brute reste faible (49 %) et ne monte à 91 % qu'après relecture par un expert : c'est un outil de débrouillage, pas un remplaçant de l'échocardiographie complète.

[Article original](#)

Electrocardiogram-Based Deep Learning to Prioritize Testing for Transthyretin Amyloid Cardiomyopathy

JAMA · 28 août 2026 · 5 cohortes multinationales et 3 cohortes de dépistage

L'amylose cardiaque à transthyréline est devenue traitable, mais son diagnostic reste tardif. Ce modèle, entraîné puis validé sur des *images* d'ECG de routine — donc déployable localement sans matériel particulier —, vise à désigner les patients chez qui pousser jusqu'à la scintigraphie osseuse. Validation externe dans cinq cohortes internationales et trois cohortes de dépistage, dont des patients opérés du canal carpien. À suivre : le passage d'un bon test au bénéfice clinique réel.

[Article original](#)

Vitamin K₂ and D₃ Supplementation in Patients With Severe Coronary Artery Calcification: The DANCODE Trial

Circulation · 28 août 2026

400 patients danois avec un score calcique ≥ 400 Agatston ont reçu vitamine K₂ (720 µg/j) plus vitamine D₃ (25 µg/j) ou un placebo pendant 24 mois. La progression du score calcique est moindre sous supplémentation : **+196** contre **+248 Agatston** (différence -52 ; IC95 % -79 à -24), sans augmentation compensatrice de la plaque non calcifiée. Le critère reste un marqueur d'imagerie : aucun événement clinique n'a été mesuré, et la différence de 52 unités est de signification pronostique inconnue. À ne pas transformer en prescription.

[Article original](#)

Safety and lipoprotein(a)-lowering effects of Kylo-11, a non-canonical, long-duration small interfering RNA targeting lipoprotein(a)

The Lancet · 28 août 2026 · premier essai chez l'homme

Course de vitesse en cours autour de la Lp(a), le facteur de risque génétique que rien ne fait baisser aujourd'hui. Chez 70 volontaires chinois à Lp(a) élevée, une **injection sous-cutanée unique** de cet ARN interférent de très longue durée d'action abaisse encore la Lp(a) à 48 semaines (réduction médiane atteignant 53 % et davantage aux fortes doses), sans effet indésirable lié au produit ni réaction au point d'injection. Phase 1 chez des sujets jeunes et sains : la question du bénéfice cardiovasculaire reste entière.

[Article original](#)

Risk of Stroke and TIA With Pulsed Field Compared With Radiofrequency Ablation for Atrial Fibrillation

Circulation · 25 août 2026 · centre universitaire américain à haut volume

L'ablation par champ pulsé s'est imposée en partie sur une promesse de sécurité. Dans ce registre de 4 221 procédures avec adjudication neurologique en aveugle, le taux d'AVC ou d'AIT à 30 jours est de **0,47 %** après champ pulsé contre **0,10 %** après radiofréquence (différence pondérée 0,36 % ; IC95 % 0,03–0,70 ; p = 0,03), sans regroupement autour d'un opérateur ni de la période d'apprentissage. Les autres complications restent inférieures à 1 % et comparables. Données observationnelles monocentriques : à confirmer, mais à connaître avant d'informer un patient.

[Article original](#)

Immediate vs Delayed Coronary Angiography After Cardiac Arrest Without ST-Segment Elevation: 5-Year Outcomes From the COACT Randomized Trial

JACC · 28 avril 2026 · 87(16):2134–2143

Suivi à 5 ans des patients de COACT (arrêt cardiaque récupéré, rythme choquable, sans sus-décalage du segment ST) : la survie reste comparable que la coronarographie soit immédiate ou différée — 54,8 % contre 51,8 % (HR 0,95 ; IC95 % 0,74–1,23). Les auteurs attribuent au hasard le bénéfice tardif observé au-delà de 90 jours dans une analyse exploratoire.

[Article original](#)

2025 Concise Clinical Guidance: An ACC Expert Consensus Statement on the Evaluation and Management of Cardiogenic Shock

JACC · 29 avril 2025 · 85(16):1618–1641

Consensus d'experts de l'American College of Cardiology consacré à l'évaluation et à la prise en charge du choc cardiogénique, publié dans la série courte « Concise Clinical Guidance ». Fiche de lecture à venir.

[Article original](#)